

TOXICIDADE QT — NEUTROPENIA FEBRIL É EMERGÊNCIA

NEUTROPENIA FEBRIL — A EMERGÊNCIA MAIS IMPORTANTE

FEBRE + NEUTROPENIA = ATB EM <1 HORA

- Definição: neutrófilos <500 (ou <1000 com previsão de queda) + Tax $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$ única ou $\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ por 1h
- Emergência: ATB de amplo espectro em <1 HORA (cada hora de atraso aumenta a mortalidade)
- Colher hemoculturas (2 sítios, incluindo cateter) ANTES do ATB — mas não atrasar o ATB
- ATB empírico: cefepima OU piperacilina-tazobactam OU meropeném (cobertura antipseudomonas)
- Adicionar vancomicina se: instabilidade, infecção de cateter, mucosite grave, suspeita de MRSA
- Estratificar risco (MASCC): baixo risco pode considerar ATB oral/ambulatorial; alto risco interna

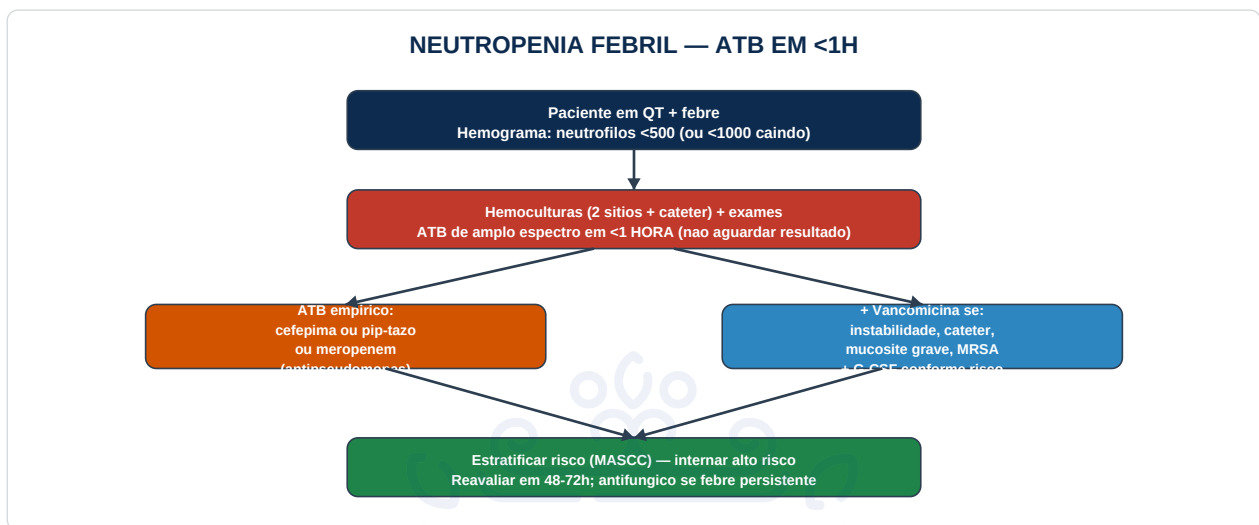
MUCOSITE — GRADUAÇÃO E MANEJO

Grau	Características	Conduta
Grau 1	Eritema, sensibilidade, sem dor importante	Higiene oral, bochechos com SF/bicarbonato
Grau 2	Úlceras, dor, consegue se alimentar (sólidos/pastosos)	Analgesia tópica + sistêmica, dieta adaptada
Grau 3	Úlceras dolorosas, só tolera líquidos	Analgesia opioide, hidratação IV, avaliar internação
Grau 4	Não consegue se alimentar, risco de vida	Internação, nutrição parenteral, opioide IV
Crioterapia	Gelo na boca durante infusão (ex: 5-FU em bolus)	Prevenção da mucosite

OUTRAS TOXICIDADES AGUDAS DA QT

Toxicidade	Quimioterápicos	Manejo
Náuseas/vômitos	Cisplatina, antraciclinas, ciclofosfamida	Ondansetrona + dexametasona + aprepitanto (esquemas)
Diarreia grave	Irinotecano, 5-FU, capecitabina	Hidratação, loperamida; octreotida se grave
Neutropenia	Maioria dos citotóxicos	G-CSF (filgrastim) profilático/terapêutico; ATB se febre
Cardiotoxicidade	Antraciclinas (doxorubicina), trastuzumabe	Monitorar FEVE; suspender se queda
Nefrotoxicidade	Cisplatina, metotrexato	Hidratação; leucovorina (resgate do MTX)
Extravasamento de vesicante	Antraciclinas, vincristina	Parar infusão, antídoto específico, gelo/calor conforme droga

ABORDAGEM DA NEUTROPENIA FEBRIL



OUTRAS EMERGÊNCIAS ASSOCIADAS

Síndrome de Lise Tumoral

- Tumores de alta carga/proliferação (linfoma Burkitt, leucemias) após QT
- HiperK + hiperfosfatemia + hiperuricemia + hipocalcemia → IRA, arritmia
- Prevenção: hidratação vigorosa + alopurinol (ou rasburicase em alto risco)
- Tratamento: corrigir distúrbios, rasburicase, diálise se refratário
- Monitorar eletrólitos e função renal de perto

Cuidados Gerais no PS

- Náuseas/vômitos: antieméticos (ondansetrona, dexametasona)
- Desidratação por diarreia/vômito: reidratação IV + correção de eletrólitos
- Anemia/plaquetopenia: transfusão conforme limiares e sintomas
- Sempre perguntar: qual QT, há quanto tempo, último ciclo (nadir ~7-14 dias)
- Mucosite: analgesia, higiene oral, suporte nutricional
- Considerar imunoterapia: toxicidades imunomediadas (colite, pneumonite) — corticoide

PONTOS-CHAVE NO PS

PACIENTE ONCOLÓGICO EM QT COM SINTOMAS

- ☐ Febre em paciente em QT = neutropenia febril até prova em contrário — hemograma urgente
- ☐ Neutropenia febril: ATB de amplo espectro em <1 hora (cefepima/pip-tazo/meropeném)
- ☐ Hemoculturas antes do ATB (incluindo do cateter), mas sem atrasar o antibiótico
- ☐ Mucosite: graduar e tratar dor (tópico → opioide); avaliar internação se grau 3-4
- ☐ Lembrar da síndrome de lise tumoral em tumores de alta carga após QT
- ☐ Sempre documentar: esquema de QT, data do último ciclo e nadir esperado (7-14 dias)

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente em quimioterapia há 10 dias chega com febre de 38,5°C. Hemograma: neutrófilos 300/mm³. Qual é a conduta imediata?

- A) Antitérmico e observação domiciliar
- B) Hemoculturas + antibiótico de amplo espectro (cefepima/pip-tazo) em menos de 1 hora
- C) Aguardar o resultado da hemocultura antes de iniciar o antibiótico
- D) Antibiótico oral e alta
- E) Apenas G-CSF (filgrastim) sem antibiótico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual antibiótico empírico é adequado para neutropenia febril, cobrindo *Pseudomonas*?

- A) Amoxicilina oral
- B) Cefepima (ou piperacilina-tazobactam ou meropeném)
- C) Azitromicina
- D) Ceftriaxona isolada
- E) Clindamicina

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Em qual situação deve-se ADICIONAR vancomicina ao esquema empírico da neutropenia febril?

- A) Em todos os casos, sempre
- B) Instabilidade hemodinâmica, infecção de cateter, mucosite grave ou suspeita de MRSA
- C) Apenas quando a febre passa de 40°C
- D) Somente em pacientes idosos
- E) Nunca deve ser usada na neutropenia febril

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente com linfoma de alto grau, após primeiro ciclo de QT, desenvolve hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia e insuficiência renal. Qual é o diagnóstico?

- A) Neutropenia febril
- B) Síndrome de lise tumoral
- C) Mucosite grau 4
- D) Cardiotoxicidade por antraciclina
- E) Nefrotoxicidade por cisplatina isolada

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual medida é eficaz na PREVENÇÃO da síndrome de lise tumoral em paciente de alto risco?

- A) Restrição hídrica
- B) Hidratação vigorosa + alopurinol (ou rasburicase em alto risco)
- C) Diurético tiazídico
- D) Suplementação de potássio
- E) Antibiótico profilático

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Neutropenia febril (neutrófilos <500 + febre) é emergência oncológica. Conduta: hemoculturas (2 sítios + cateter) + antibiótico de amplo espectro com cobertura antipseudomonas (cefepima, pip-tazo, meropeném) em <1 hora. Não aguardar resultado de cultura — cada hora de atraso aumenta a mortalidade.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O ATB empírico da neutropenia febril deve cobrir *Pseudomonas*: cefepima, piperacilina-tazobactam ou meropeném (monoterapia de amplo espectro). Adicionar vancomicina apenas em situações específicas (instabilidade, cateter, mucosite grave, MRSA).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Vancomicina não é rotina na neutropenia febril. Adicionar quando: instabilidade hemodinâmica/seps, infecção de cateter (celulite/bacteremia), mucosite grave, pneumonia, colonização/suspeita de MRSA ou de *Streptococcus* resistente. Reavaliar e descalonar em 48-72h se cultura negativa.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Síndrome de lise tumoral: liberação maciça de conteúdo celular após QT em tumores de alta carga/proliferação (Burkitt, leucemias). Tétrade: hipercalemia + hiperfosfatemia + hiperuricemia + hipocalcemia → IRA e arritmias. Prevenção: hidratação + alopurinol/rasburicase.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Prevenção da síndrome de lise tumoral em alto risco: hidratação vigorosa (mantém diurese e excreção) + alopurinol (reduz produção de ácido úrico) ou rasburicase (degrada ácido úrico, em alto risco). Monitorar eletrólitos e função renal. Diálise se distúrbios refratários.

SM24
Suporte ao Plantão Médico